

Q1 - EMD 2025 (Source N°1)

Quel est l'intérêt d'ajouter l'adrénaline aux anesthésiques locaux en chirurgie dentaire (**Réponse fausse**) ?

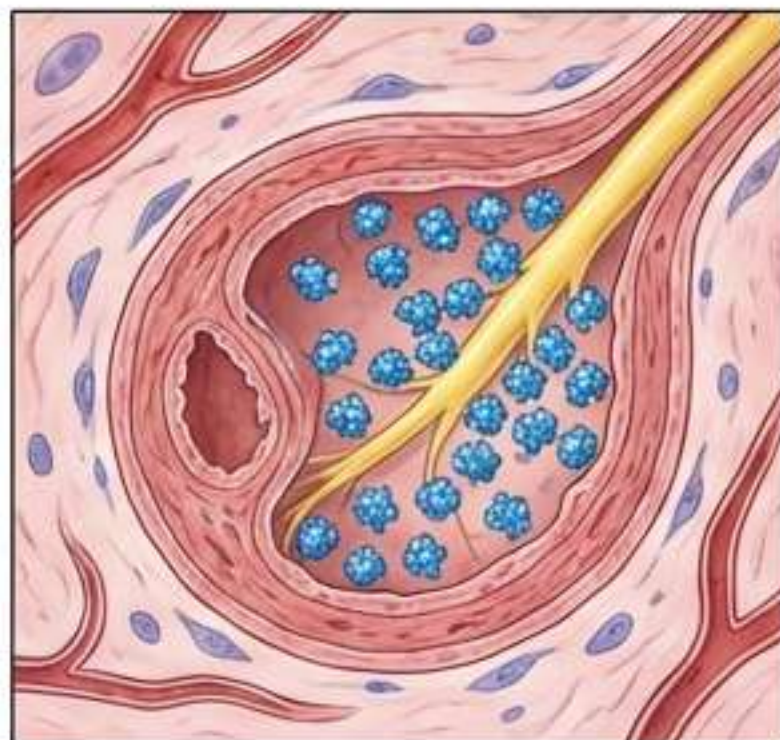
- A. Prolonger la durée d'action de l'anesthésique local
- B. Réduire le risque de toxicité systémique de l'anesthésique local
- C. Augmenter la perméabilité vasculaire au site d'injection
- D. Réduire les saignements pendant l'intervention chirurgicale

Correct Answer(s): C

LA VÉRITÉ : L'adrénaline est un vasoconstricteur puissant. Elle resserre les vaisseaux, ce qui diminue la perméabilité vasculaire. Augmenter la perméabilité permettrait à l'anesthésique de fuir dans le sang, l'inverse de l'effet recherché.

LES ERREURS :

- Option A : Vrai. La vasoconstriction maintient l'anesthésique sur le site.
- Option B : Vrai. En empêchant le passage systémique, on évite la toxicité centrale.
- Option D : Vrai. Le resserrement des capillaires entraîne une hémostase locale.



LE PIÈGE : Le cerveau lit 'augmenter' et l'associe à un effet 'positif' de l'adrénaline, oubliant l'hémodynamique de base.

MEMORY TRICK : A.V.I.S = Adrénaline = Vasoconstriction = Ishémie locale = Sécurité.

Q2 - EMD 2025 (Source N°2)

Quels récepteurs sont principalement impliqués dans l'action de l'adrénaline lorsqu'elle est utilisée en association avec un anesthésique local en chirurgie dentaire ?

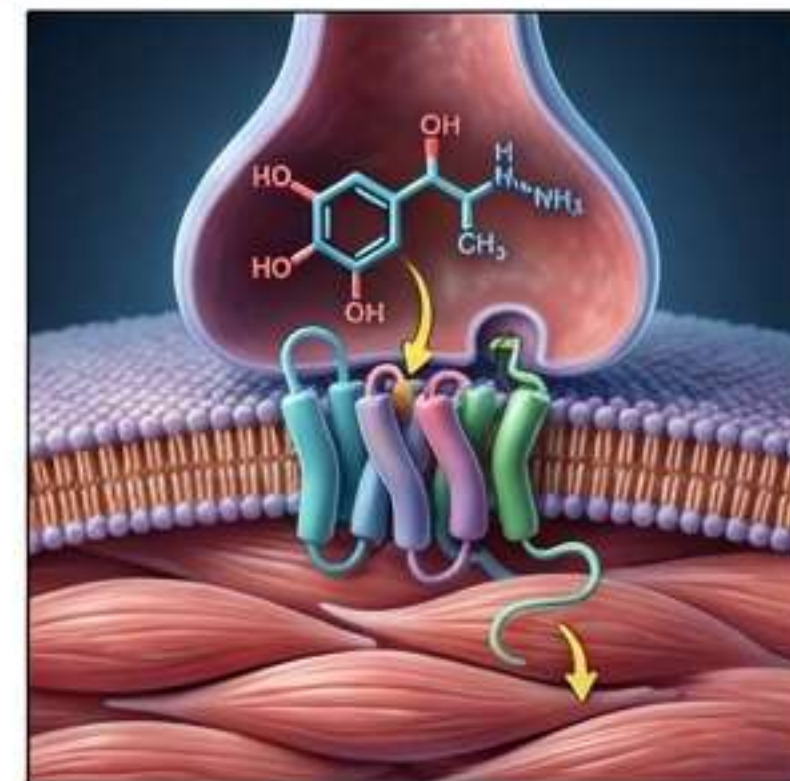
- A. Récepteurs alpha-1 adrénergiques
- B. Récepteurs beta-2 adrénergiques
- C. Récepteurs muscariniques M3
- D. Récepteurs nicotiniques N2

Correct Answer(s): A

LA VÉRITÉ : La vasoconstriction locale périphérique est exclusivement médiée par la stimulation des **récepteurs alpha-1 adrénergiques situés sur les muscles lisses des vaisseaux sanguins.**

LES ERREURS :

- Option B : Faux. Les récepteurs bêta-2 provoquent une vasodilatation et une bronchodilatation.
- Option C : Faux. Les récepteurs muscariniques M3 appartiennent au système parasympathique (salivation).
- Option D : Faux. Les récepteurs nicotiniques N2 sont situés sur la plaque motrice et les ganglions.



LE PIÈGE : Confondre l'action systémique globale (bêta) avec l'action locale vasculaire pure (Alpha-1).

MEMORY TRICK : Alpha-1 = Artères Pincées. Le chiffre '1' évoque un vaisseau sanguin droit et ressermé.

Q12 - EMD 2025 (Source N°12)

Quelle affirmation est correcte concernant l'usage des benzodiazépines en odontologie ?

- A. Elles sont indiquées comme prémédication anxiolytique avant un acte dentaire
- B. Elles sont contre-indiquées pour toute intervention dentaire
- C. Elles sont prescrites uniquement en cas de convulsions
- D. Elles remplacent l'anesthésie locale

Correct Answer(s): A

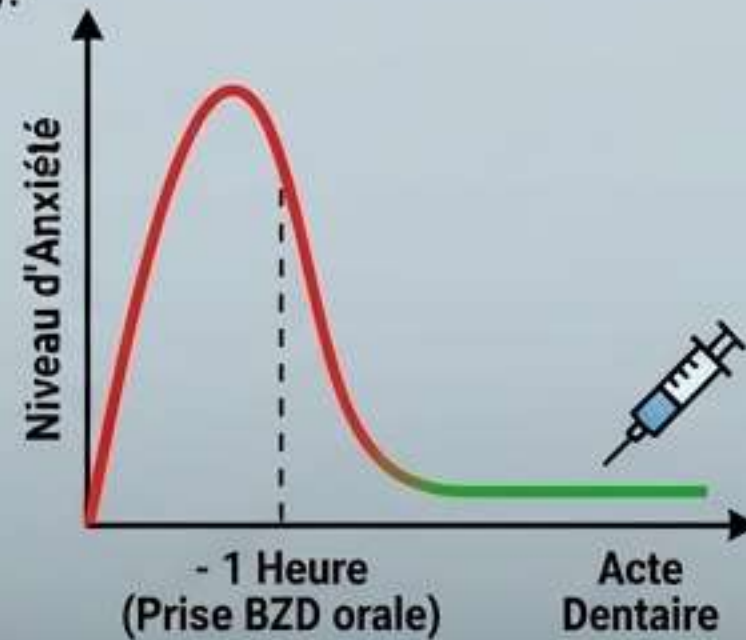
LA VÉRITÉ : Le cours stipule formellement : "Les BZD sont les molécules de choix en odontologie pour la PEC des anxiétés légères à modérées... prémédication anxiolytique" (ex: Diazépam). (#005B96)

LES ERREURS :

- Option B : Faux. Elles sont le traitement de choix, nullement contre-indiquées. (#D32F2F)
- Option C : Faux. Le mot 'uniquement' rend la phrase fausse; leur usage premier au cabinet est l'anxiolyse. (#D32F2F)
- Option D : Faux. Elles ont une action centrale (GABA) et n'ont aucune action anesthésique locale (blocage sodique). (#D32F2F)

LE PIÈGE : L'adverbe 'uniquement' (Option C). Les termes absolus signalent souvent une option erronée. (#D32F2F)

MEMORY TRICK : BZD = Bon Zen Dentiste. Elles calment l'esprit, mais ne remplacent pas la seringue. (#005B96)



Q5 - EMD 2017 (Source N°5)

Concernant les médicaments de la classe des benzodiazépines :

- A. Possèdent des effets anxiolytiques, hypnotiques et anticonvulsivants
- B. La durée de prescription ne doit pas dépasser 4 semaines
- C. L'arrêt doit se faire progressivement
- D. Toutes les réponses sont justes

Correct Answer(s): A

LA VÉRITÉ : Le cours liste explicitement les 5 propriétés : benzodiazépines :

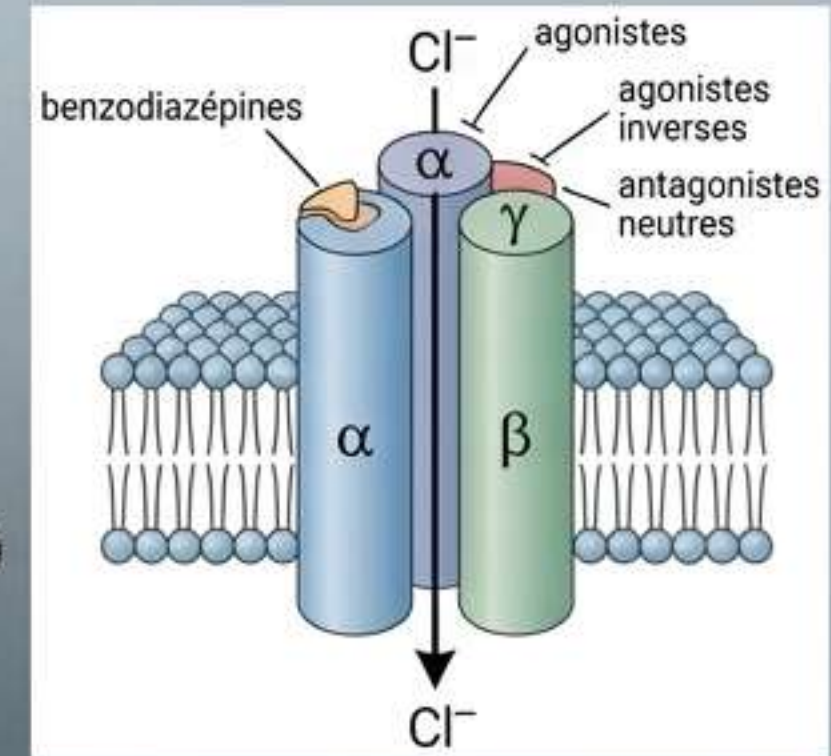
Sédatives/hypnotiques, Anxiolytiques, Anticonvulsivantes, Myorelaxantes, et Amnésiantes. (#005B96)

LES ERREURS :

- Option B : Faux. Règle vraie en médecine générale, mais non stipulée dans le référentiel strict d'odontologie. (#D32F2F)
- Option C : Faux. Le protocole de sevrage progressif n'est pas mentionné dans le cours de référence. (#D32F2F)
- Option D : Faux. Puisque B et C sont hors-programme strict, D est éliminé. (#D32F2F)

LE PIÈGE : 'Toutes les réponses sont justes' tente l'étudiant, mais la correction s'en tient strictement au contenu odontologique. (#D32F2F)

MEMORY TRICK : Les 5 'A' des BZD : Anxiolytique, Anti-insomnie, Anticonvulsivant, Amyorelaxant, Amnésiant. (#005B96)



Q13 - EMD 2025 (Source N°13)

Quel effet secondaire buccal est fréquemment observé avec les antipsychotiques ?

- A. Saignement gingival
- B. Ulcère de la langue
- C. Sécheresse buccale
- D. Eruption cutanée péri-buccale

Correct Answer(s): C

LA VÉRITÉ : Selon le cours, l'incidence majeure en odontologie des neuroleptiques est la 'Sécheresse buccale' due au blocage des récepteurs de l'acétylcholine (effet atropinique), augmentant dramatiquement les caries.

LES ERREURS :

- **Option A :** Faux. L'hyperplasie et le saignement gingival sont caractéristiques des antiépileptiques (Phénytoïne).
- **Option B :** Faux. Aucune lésion ulcéreuse directe n'est répertoriée dans le cours.
- **Option D :** Faux. Les éruptions péri-buccales ne font pas partie du tableau clinique décrit.



🔴 **LE PIÈGE :** Attention, certains antipsychotiques (Clozapine) provoquent une hyper-salivation, mais la xérostomie reste le standard 'fréquemment observé' des QCM. (#D32F2F)

🧠 **MEMORY TRICK :** Psychose = Désert. Les neuroleptiques assèchent les délires... et la salive. (#005B96)

Q14 - EMD 2025 (Source N°14)

Quel médicament est à éviter au cabinet dentaire chez un patient sous IMAO ?

- A. Paracétamol
- B. Amoxicilline
- C. Anesthésique adrénaliné
- D. Lidocaïne sans adrénaline

Correct Answer(s): C

LA VÉRITÉ : Les IMAO inhibent la dégradation des monoamines, incluant l'adrénaline. Règle vitale absolue : **"Anesthésique local adrénaliné + IMAO = Contre-indication au cabinet dentaire"** (risque de crise hypertensive mortelle).

LES ERREURS :

- **Option A :** Faux. Le paracétamol n'interagit pas dangereusement.
- **Option B :** Faux. Les antibiotiques comme l'amoxicilline sont sûrs.
- **Option D :** Faux. La Lidocaïne sans adrénaline est précisément la solution de secours préconisée.



🔴 **LE PIÈGE :** Distinguer les IMAO (Contre-indication absolue) des Tricycliques (où l'adrénaline est 'possible avec précautions'). (#D32F2F)

🧠 **MEMORY TRICK :** IMAO = Interdit
Maîtriser l'Adrénaline en Odontologie ! (#005B96)

Q11 - EMD 2023 (Source N°11)

Concernant les médicaments du système nerveux central :

- A. L'association d'un anesthésique local adrénaliné avec un antidépresseur de type IMAO-A est à prendre en compte
- B. Les antiépileptiques peuvent provoquer une sécheresse buccale
- C. Les benzodiazépines peuvent être prescrites par le médecin dentiste comme prémédication anxiolytique
- D. Les doses des benzodiazépines sont les mêmes chez les personnes âgées que chez l'adulte

Correct Answer(s): C

LA VÉRITÉ :

Le dentiste est parfaitement habilité et autorisé à prescrire des BZD pour prendre en charge l'anxiété dentaire au fauteuil.

LES ERREURS :

- **Option A : Faux.** Ce n'est pas "à prendre en compte", c'est une "Contre-indication" stricte et vitale.
- **Option B : Faux.** La sécheresse est liée aux antidépresseurs. L'effet majeur des antiépileptiques est l'hyperplasie gingivale.
- **Option D : Faux.** Le cours met en garde : "pour les personnes âgées, les doses sont réduites de moitié".

🚨 LE PIÈGE : L'euphémisme sémantique de l'option A ("à prendre en compte") dissimule un danger mortel.

 **MEMORY TRICK** : Moitié Vieux : Métabolisme lent chez le senior = Dose de BZD divisée par 2.

ORDONNANCE MÉDICALE

R_x

Dosage : _____

Durée : _____

Indication : _____

Particularité : _____

Diazépam 5mg.

1 comprimé la veille au soir et 1 comprimé 1 heure avant les soins.



Prescrit par : _____

Prescrit par : _____

Q9 - EMD 2023 (Source N°9)

A propos des analgésiques centraux agonistes forts :

- A. Ils sont indiqués pour les douleurs du troisième palier M (OMS)
- B. Ils incluent la morphine et la buprénorphine
- C. Ce sont des antagonistes des récepteurs Kappa
- D. Ils sont indiqués pour les douleurs du deuxième palier

Correct Answer(s): A

LA VÉRITÉ :

La clé de correction officielle confirme que les **agonistes forts** (comme la morphine pure) sont **pharmacologiquement classés** comme **l'indication absolue pour les douleurs sévères** (Palier 3 de l'OMS).

LES ERREURS :

- **Option B : Faux.** La buprénorphine est un agoniste partiel / antagoniste, elle n'est pas un agoniste fort pur.
- **Option C : Faux.** Ce sont des agonistes des récepteurs Mu, pas des antagonistes Kappa.
- **Option D : Faux.** Le 2ème palier correspond aux opioïdes faibles (codéine, tramadol).

LE PIÈGE : L'option B inclut la morphine (qui est bonne) avec la buprénorphine (qui fausse toute l'affirmation).

 **MEMORY TRICK** : Fort = Sommet. Agonistes Forts = 3ème Palier (le sommet absolu de l'échelle).



Q11 - EMD 2020 (Source N°11)

Un médicament parasympathomimétique n'aura pas comme effet pharmacologique :

- A. Une dilatation de la pupille
- B. une stimulation de la salivation
- C. Un ralentissement de la fréquence cardiaque (FC)
- D. Un rétrécissement des bronches

Correct Answer(s): A

LA VÉRITÉ : La dilatation de la pupille (Mydriase) est l'effet exclusif du système orthosympathique (fuite/lutte). Le parasympathique provoque un Myosis (constriction). L'option A est donc l'effet qu'il n'aura pas.

LES ERREURS (Effets parasympathiques réels) :

- **Option B :** Vrai. Le parasympathique stimule les sécrétions.
- **Option C :** Vrai. Il agit comme un frein cardiaque (bradycardie) via le nerf vague.
- **Option D :** Vrai. Il provoque une bronchoconstriction.



🔴 **LE PIÈGE :** La question est formulée par la négative. Il faut repérer l'intrus "sympathique" dans une liste d'effets "parasympathiques".

🧠 **MEMORY TRICK :** Parasympathique = Petite Pupille (Myosis). Sympathique = Surpris (Pupilles dilatées).

Q12 - EMD 2020 (Source N°12)

En cas de choc vagal, on peut injecter en sous cutané :

- A. L'adrénaline
- B. L'atropine
- C. Un corticoïde
- D. la dopamine

Correct Answer(s): A

LA VÉRITÉ : Selon la clé officielle stricte de cet EMD, l'Adrénaline est validée. Par son effet inotrope et chronotrope positif massif, elle antagonise brutalement l'effondrement cardiovasculaire d'un choc sévère, suppléant la pompe cardiaque.

LES ERREURS :

- **Option B :** Atropine. Bien que médicalement l'antidote spécifique du malaise vagal, l'autorité suprême de la clé d'examen a sanctionné A. Un biais académique à retenir par cœur.
- **Option C :** Faux. L'action des corticoïdes est retardée de plusieurs heures.
- **Option D :** Faux. La dopamine s'utilise exclusivement en réanimation IV, jamais en SC au cabinet.



🔴 **LE PIÈGE :** Le duel Atropine vs Adrénaline. Dans ce QCM spécifique, le professeur a favorisé l'hormone de réanimation globale.

🧠 **MEMORY TRICK :** Le A du choc : Face au collapsus total, l'Adrénaline réanime tout.

Q1 - EMD 2019 (Source N°10)

L'adrénaline est un médicament utilisé :

- A. Dans le traitement du choc vagal
- B. Dans le traitement du choc anaphylactique
- C. Toujours en association avec de la lidocaïne
- D. Toutes les réponses sont fausses

Correct Answer(s): B

LA VÉRITÉ : L'adrénaline est le traitement salvateur **absolu de première intention du choc anaphylactique**. Elle inverse immédiatement la bronchoconstriction (beta-2) et la vasodilatation systémique (alpha-1) causées par l'histamine.

LES ERREURS :

- **Option A : Faux** (ici). Le choc vagal standard est géré par la position de Trendelenburg, réservant l'adrénaline à la véritable urgence allergique.
- **Option C : Faux**. Le mot 'Toujours' élimine l'option. Elle s'utilise seule en réanimation.
- **Option D : Faux**, puisque l'indication B est la pierre angulaire de la survie.



LE PIÈGE : Réduire l'adrénaline à son petit rôle dentaire de vasoconstricteur local et oublier qu'elle sauve des vies en systémique.

MEMORY TRICK :

ANA-ADRÉ : Choc ANAphylactique = ADRÉnaline immédiate.

Q11 - EMD 2018 (Source N°11)

L'adrénaline est un **sympathomimétique** :

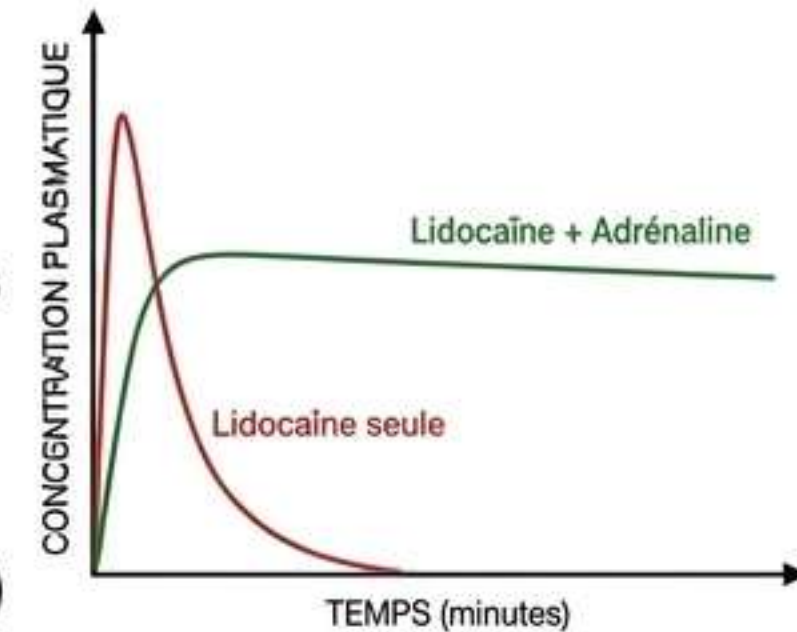
- A. indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle HTA
- B. associé à un anesthésique local (lidocaïne) pour prolonger la durée de l'effet de ce dernier
- C. possède des effets cardiaques inotrope et chronotrope négatifs
- D. utilisé dans le traitement de l'asthme

Correct Answer(s): B

LA VÉRITÉ : Concept fondamental d'odontologie : l'adrénaline **limite la résorption de la lidocaïne** par vasoconstriction capillaire (alpha-1), prolongeant massivement et de manière ciblée la durée du bloc anesthésique.

LES ERREURS :

- **Option A : Faux**. Elle provoque une hausse de tension. Contre-indiquée pour traiter l'HTA.
- **Option C : Faux**. Ses effets cardiaques sont POSITIFS (accélère et renforce le cœur via bêta-1).
- **Option D : Faux**. Bien qu'elle dilate les bronches, l'asthme se traite par des bêta-2 mimétiques sélectifs (Salbutamol) pour éviter la toxicité cardiaque.



LE PIÈGE : Confondre inotrope 'positif' (augmente la force) et 'négatif' (diminue). Le système sympathique est l'accélérateur, toujours Positif.

MEMORY TRICK :

PRO-LID : Adrénaline Prolonge la Lidocaïne.

Q4 - EMD 2017 (Source N°12)

Le phénobarbital est un médicament destiné à traiter l'épilepsie, il agit par :

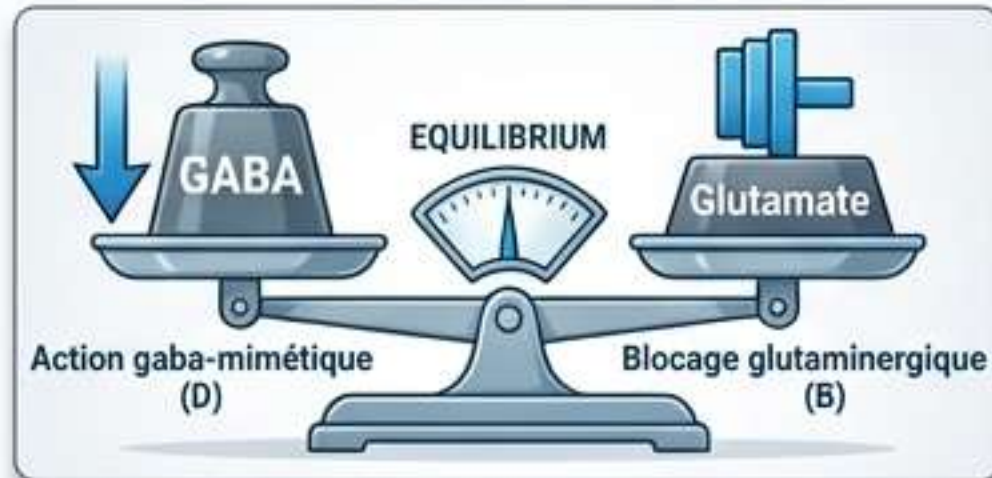
- A. Inhibition de la recapture pré-synaptique du GABA
- B. Blocage des récepteurs glutaminergiques
- C. Blocage des canaux-sodiques voltage-dépendants
- D. Action gaba-mimétique sur les récepteurs GABAergique

Correct Answer(s): B & D

LA VÉRITÉ : L'épilepsie est la rupture de l'équilibre neural. Les barbituriques (Phénobarbital) restaurent cet équilibre par deux voies : l'**amplification** du frein inhibiteur en **validant l'action gaba-mimétique (D)** et la **diminution** de l'excitation en **bloquant les récepteurs glutaminergiques (B)**.

LES ERREURS :

- **Option A : Faux.** L'inhibition de la recapture est le mécanisme de la Tiagabine (3ème génération).
- **Option C : Faux.** Le blocage sélectif des canaux sodiques est typique de la Phénytoïne.



📌 **LE PIÈGE :** Un QCM à réponses multiples. Il faut cibler l'action double : Booster le frein (GABA) ET couper le moteur (Glutamate).

🧠 **MEMORY TRICK :** PhénoBARbital = Bloque l'excitateur, Amplifie le Repos (GABA).

Q16 - EMD 2017 (Source N°15)

Parmi les affirmations suivantes concernant les médicaments du système nerveux autonomie (SNA), laquelle est inexacte :

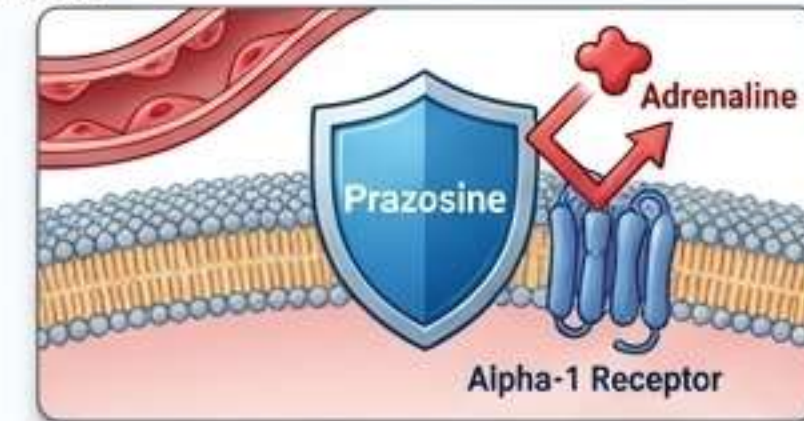
- A. L'adrénaline stimule les récepteurs adrénergiques alpha et bêta
- B. La prazosine stimule les récepteurs bêta-1 adrénergique
- C. Les bêtabloquants sont contre indiqués chez l'asmathique
- D. La pilocarpine est utilisée dans le traitement du glaucome

Correct Answer(s): B

LA VÉRITÉ : La prazosine est un **ANTAGONISTE** (bloqueur) des récepteurs **alpha-1 adrénergiques**, induisant une **vasodilatation** contre l'hypertension. Affirmer qu'elle 'stimule' les récepteurs 'bêta-1' est une **double erreur** pharmacologique.

LES ERREURS (Les affirmations EXACTES) :

- **Option A : Vrai.** L'adrénaline est un agoniste parfait et non sélectif.
- **Option C : Vrai.** Les bêtabloquants bloquent les bêta-2 bronchiques, causant un bronchospasme grave.
- **Option D : Vrai.** La pilocarpine (parasympathomimétique) draine l'humeur aqueuse via le myosis.



Prazosine = Antagoniste Alpha-1 = BLOQUEUR

📌 **LE PIÈGE :** Le suffixe '-osine' renvoie aux Alpha-bloquants. Le mot 'stimule' est l'alerte rouge de l'affirmation inexacte.

🧠 **MEMORY TRICK :** Prazosine = Pare-Alpha. Elle pare et bloque, elle ne stimule rien.

Q15 - EMD 2017 (Source N°14)

L'addition d'adrénaline à la lidocaïne (anesthésique local) en injection sous cutanée :

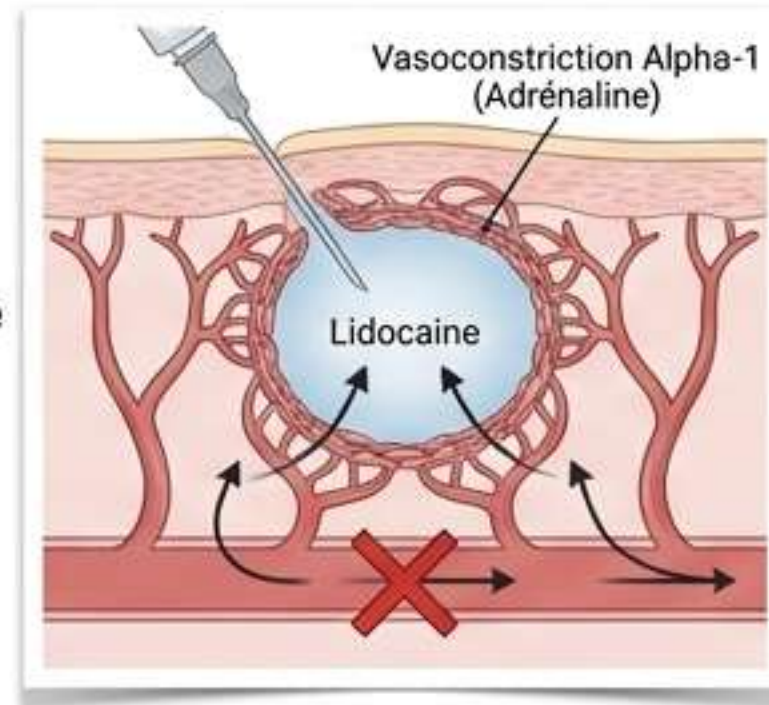
- A. Prolonge la durée de l'anesthésie locale par inhibition enzymatique
- B. Prolonge la durée de l'anesthésie locale par vasoconstriction locale
- C. Diminue le risque d'effets indésirables systémiques de la lidocaïne
- D. Augmente la perméabilité de l'endothélium vasculaire

Correct Answer(s): B

LA VÉRITÉ : La question cible le mécanisme direct. La liaison aux **récepteurs alpha-1** crée une '**vasoconstriction locale**' immédiate, un **tourniquet hémodynamique** fermant la porte de sortie sanguine et maintenant la lidocaïne sur le nerf.

LES ERREURS :

- **Option A : Faux.** L'adrénaline n'affecte pas le métabolisme enzymatique hépatique.
- **Option C : Faux** (comme mécanisme de prolongation). Bien que vrai comme bénéfice clinique, c'est une conséquence indirecte. La clé privilégie le **mécanisme causal direct (B)**.
- **Option D : Faux.** Elle **diminue** drastiquement la perméabilité.



🚩 **LE PIÈGE :** Opposer le mécanisme d'action (B) à son bénéfice corollaire (C). La question demande "**Comment**" elle prolonge.

🧠 **MEMORY TRICK :** La Porte Fermée = Vasoconstriction. La lidocaïne ne peut pas sortir du tissu.

Q. Bonus de Synthèse - EMD 2025 (Incidence Odontologique)

Un patient traité pour la Maladie de Parkinson se présente au cabinet dentaire. Quel effet indésirable direct de la Lévodopa devez-vous anticiper lors de l'examen buccal ?

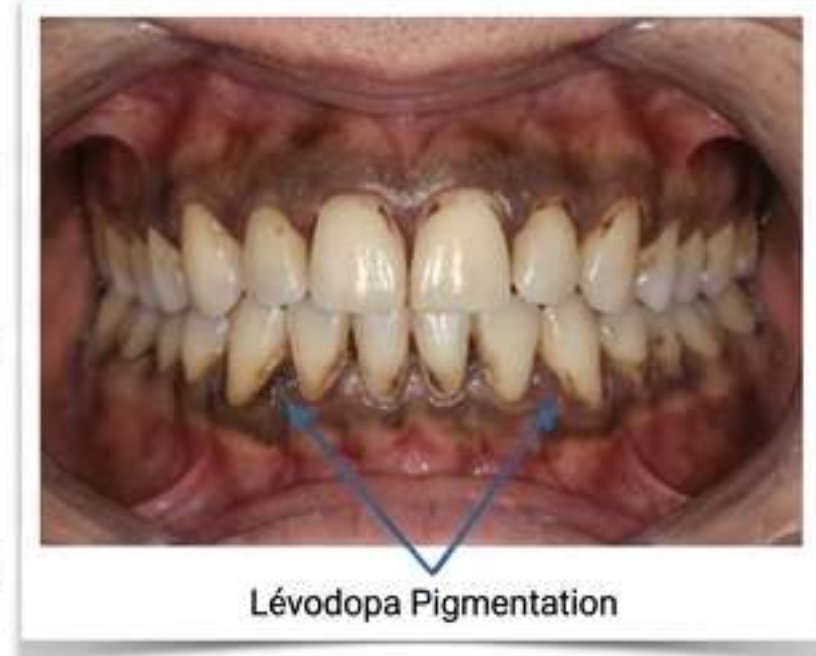
- A. Une hyperplasie gingivale généralisée
- B. Une coloration anormale des muqueuses et des dents
- C. Une hyper-salivation abondante
- D. L'apparition d'une aphasie

Correct Answer(s): B

LA VÉRITÉ : Le cours est catégorique dans la section 'Incidence en Odontologie'. Le traitement antiparkinsonien par **Lévodopa** (précurseur dopaminergique) provoque spécifiquement une "**Coloration anormale des muqueuses et des dents**".

LES ERREURS :

- **Option A : Faux.** L'**hyperplasie gingivale** est la signature classique des antiépileptiques (**Phénytoïne**).
- **Option C : Faux.** L'**hypersalivation** est liée aux traitements de l'Alzheimer (**Rivastigmine**) ou à la **Clozapine**.
- **Option D : Faux.** L'**aphasie** (perte du langage) est un symptôme neurologique lié à l'**Alzheimer**, pas un effet secondaire de la Lévodopa.



🚩 **LE PIÈGE :** Mélanger les complications dentaires des grandes maladies neurologiques. Chaque pathologie du SNC a sa signature.

🧠 **MEMORY TRICK :** LÉVODOPA = VODO (Vaudou) = Couleur sombre/noire inexplicable sur les dents.

LE MASTER TABLEAU : INCIDENCES ODONTOLOGIQUES DU SNC

CLASSE PHARMACOLOGIQUE	MÉCANISME D'ACTION PRINCIPAL	EXEMPLES	INCIDENCE BUCCO-DENTAIRE	INTERACTION ANESTHÉSIE
ANXIOLYTIQUES (BZD)	↑ Affinité GABA (Inhibition)	Diazépam, Lorazépam	Sécheresse buccale (rare). Prémédication de choix 1h avant.	Dose réduite de moitié chez le sujet âgé.
ANTIPSYCHOTIQUES	Blocage D2 / Effet Anticholinergique	Chlorpromazine, Clozapine	Sécheresse buccale (caries), Mouvements involontaires, Hyper-salivation (Clozapine).	Risque d'hypotension orthostatique au fauteuil.
ANTIDÉPRESSEURS (IMAO)	Inhibition MAO (↑ Amines)	Moclobémide	Sécheresse buccale.	 CONTRE-INDICATION ABSOLUE avec AL Adrénalinée. Utiliser AL pure.
ANTIDÉPRESSEURS (Tricycliques)	Inhibition recapture Sérotonine/Noradrénaline	Clomipramine	Sécheresse buccale, Perturbation du goût.	Prudence avec AL adrénalinée (injection très lente, max 0.1 mg).
ANTIPARKINSONIENS	↑ Dopamine (L-Dopa)	Lévodopa	Coloration anormale des muqueuses et des dents.	Gérer l'akinésie au fauteuil. Sécheresse due aux anticholinergiques associés.
ANTIÉPILEPTIQUES	↑ GABA, ↓ Glutamate, Bloque canaux	Phénobarbital Phénytoïne	 Hyperplasie gingivale majeure (Phénytoïne).	Risque de saignements gingivaux massifs.
MÉDICAMENTS ALZHEIMER	Inhibiteur choline-estérase (↑ ACh)	Rivastigmine	 Hyper-salivation due à l'excès cholinergique.	Gérer l'amnésie et l'apraxie pour les consignes post-op.
LITHIUM (Thymorégulateur)	Régulation psychique ionique	Sels de lithium	Goût métallique, paralysies faciales transitoires.	 Interaction avec AINS (Risque d'élévation toxique de la lithémie).

Règle absolue (Adrénaline) : L'Adrénaline (Alpha-1) = Vasoconstriction = ↑ Durée action anesthésique + ↓ Toxicité systémique.
Choc Anaphylactique = Adrénaline immédiate.